

Bez RP *ekspozycja jest pusta*

Kompulsja po ekspozycji „kasuje uczenie” — mózg przypisuje brak katastrofy kompulsji, nie konfrontacji. RP jest sercem ERP.

CZAS: ciągła praktyka — cały dzień Z każdą ekspozycją + między nimi

ŹRÓDŁO: Meyer (1966); Foa i Goldstein (1978); Foa i wsp. (1985)

JAK UŻYWAĆ

Po ekspozycji **nie wykonuj kompulsji** — ani fizycznej, ani *mentalnej*. Trzy formy: **pełne** RP (zero kompulsji — wzorzec), **częściowe** RP (stopniowe ograniczanie), **opóźnione** RP („poczekam 15 min — często impuls mija”). Zidentyfikuj *wszystkie* swoje kompulsje, w tym subtelne mentalne.

DLACZEGO TO DZIAŁA

RP (ang. *response prevention*, „powstrzymanie reakcji”) to **powstrzymanie się od kompulsji po ekspozycji** — najtrudniejszy element protokołu, ale *bez RP ekspozycja jest niemal nieskuteczna* (Foa i wsp., 1985). Mechanizm: po ekspozycji pacjent „dla pewności” myje ręce 5 minut, sprawdza zamek 3x, modli się w myślach. Mózg przypisuje bezpieczeństwo *tej czynności*, a nie rzeczywistemu brakowi zagrożenia. Cała ekspozycja idzie na marne — uczenie nie utrwała się. Meyer (1966): pierwsze udokumentowane zastosowanie RP w OCD. Foa i Goldstein (1978): formalizacja jako ERP (*Exposure + Response Prevention*) — dziś standard NICE i APA.

01 ☞ Dwa typy kompulsji — obie wymagają RP

BEHAWIORALNE — WIDOCZNE

- Mycie rąk, prysznica, dezynfekcja
- Sprawdzanie zamków, kuchenki, dokumentów
- Układanie symetryczne, „just right”
- Liczenie głośne lub w głowie
- Powtarzanie czynności w „bezpiecznej” liczbie
- Unikanie miejsc/przedmiotów

Łatwiejsze do RP — pacjent je widzi.

MENTALNE — UKRYTE

- **Analizowanie:** „czy naprawdę bym to zrobił?”
- **Neutralizacja:** zastąpienie „złej” myśli „dobrą”
- **Modlitwy** w głowie, powtarzanie „bezpiecznych” zdań
- **Szukanie zapewnienia** w sobie
- Mentalne **sprawdzanie wspomnień**
- Liczenie w głowie

Trudniejsze do RP — pacjent ich nie zauważa.

Kompulsje mentalne są równie szkodliwe jak behawioralne — i często *ważniejsze* w utrzymywaniu OCD. Bez RP w warstwie mentalnej postęp jest niepełny. Pacjent może „przestać sprawdzać zamek”, ale dalej w *głowie* analizuje, czy zamek na pewno zamknął — i cykl trwa.

02 ☉ Trzy formy RP — wybór strategii

1 · PEŁNE RP

Zero kompulsji. Wzorzec docelowy. *Trudne na początku.* Dla łagodnych pozycji hierarchii — od razu próbuj. Dla trudnych — po częściowym.

2 · CZĘŚCIOWE RP

Stopniowe ograniczenie. „Mycie rąk max 20 sek zamiast 5 min”. „Sprawdzanie zamka 1x zamiast 10x”. Dobre dla początku.

3 · OPÓŹNIONE RP

„Poczekam 15 min zanim sprawdzę”. Często impuls *mija sam*. Strategia przejściowa do pełnego RP.

03 Twoja mapa kompulsji — zidentyfikuj WSZYSTKIE

KOMPULSJA	TYP B / M	CZĘSTOŚĆ razy / dzień	PLAN RP pełne / częściowe / opóźnione

B = behawioralna (widoczna), M = mentalna (w głowie)

04 Ukryte pułapki RP — uważaj

SZUKANIE ZAPEWNIENIA

„Czy drzwi są zamknięte?”, „Czy to normalne?”, „Czy jestem złą osobą?” — pytanie kogoś o zapewnienie **to też kompulsja**. Powstrzymuj się.

ANALIZOWANIE

„Ale czy naprawdę bym to zrobił?”, „Co to o mnie mówi?” — **analizowanie w głowie to kompulsja mentalna**. Nie dawaj jej miejsca.

ZACHOWANIA ZABEZPIECZAJĄCE

„Tylko trochę umyję ręce”, „tylko raz sprawdzę”.
Subtelne kompulsje zachowują cały cykl. Trudne do wykrycia.

NEUTRALIZACJA

„Złą” myśl zastępujesz „dobrą” — to też **kompulsja mentalna**. Pozwól „złej” myśli być, bez interwencji.

Klucz: Foa i wsp. (1985): pacjenci stosujący ERP bez pełnego RP — efekt minimalny. Pacjenci z konsekwentnym RP — $d = 1,1-1,6$. **RP jest tym, co odróżnia ERP od „ekspozycji bez efektu”**. Po ekspozycji każda kompulsja, której się powstrzymujesz, *uczy mózg*: „**brak katastrofy wynika z braku zagrożenia, nie z mojej kompulsji**”. Pełne RP jest celem — częściowe i opóźnione są drogą. Niezależnie od formy: *identyfikuj wszystkie kompulsje, szczególnie mentalne*.